

4 血 胸 hemothorax

到達目標

- ◆ 血胸の原因疾患を列挙できる
- ◆ 血胸の診断ができる
- ◆ 血胸の治療、処置について立案できる

病因・病態

a 定 義

胸腔内に血液が貯留する病態を血胸と呼ぶ。血性胸水との違いはその濃度であり、血胸とは基本的に血液そのものが貯留することで、胸膜腔内の血性の体液（胸水）のヘマトクリット値が末梢血のヘマトクリット値の50%以上あるものとされる¹⁾。

b 病因による分類¹⁾

i) 外傷性血胸

鋭くない鈍的胸部外傷によって起こる。鈍的胸部外傷によるものでは、肋骨骨折、骨折端による肺損傷や、肺挫傷によって起こる。

ii) 医原性血胸

診断用あるいは治療用のカテーテル類による心・大血管損傷、針生検などによる血管穿刺や腫瘍損傷、胸腔ドレナージによる胸壁損傷や心・大血管損傷、胸部手術後の再出血などがある。

iii) 非外傷性血胸

- ① 自然気胸あるいは続発性気胸に伴う出血（血気胸）：多くは気胸による肺虚脱によって、胸壁と肺の間に増生していた血管が断裂して起こる。
- ② 肺・縦隔・胸壁・横隔膜などの腫瘍からの出血
- ③ 血管病変（胸部大動脈瘤、肺動静脈瘻など）の破裂

(図 1)

④ 子宮内膜症（月経随伴性気胸）

⑤ 全身性の止血異常を背景とするもの：血友病や血小板減少症など

⑥ 特発性

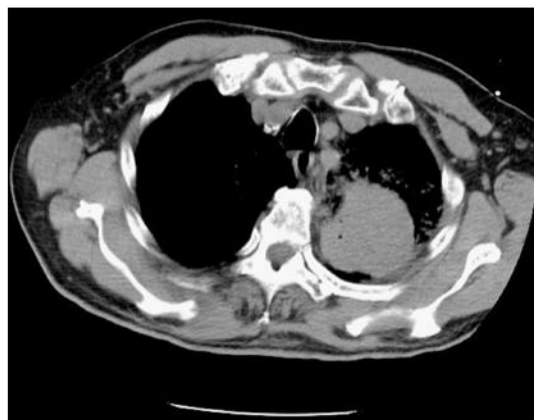
症候・身体所見

症状には病因にもよるが、咳嗽、胸痛、発熱を認める。出血量が増えると貧血や頻脈、低血圧が起こりショックを呈する。肺挫傷の場合は呼吸困難や血痰を伴うこともある。身体所見は、患側の胸膜摩擦音や呼吸音減弱を認めるが血液量が少量の場合は所見を認めない場合もある。

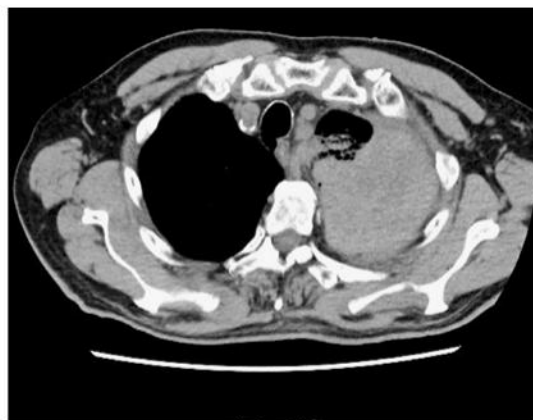
診断・検査

胸腔内に液体が貯留する病態として胸水、膿胸、乳び胸とともに血胸を念頭においておくことが肝要である。胸部外傷では、まず血胸の存在を疑い、胸腔内の液体貯留をみれば血胸と考えるのが妥当であり、初期対応では胸部超音波検査が有用である。

胸部単純X線検査では可能な限り立位ないし座位で行うと、胸腔内の液体貯留がわかりやすい。血胸を確認するためには胸腔穿刺が必要であり、原因推定と穿刺部位を決定するためにも胸部CTが望ましい。少量の胸腔内の液体貯留が胸部CTで診断されることもある。胸部CTで血胸は胸水に比べ高いCT値（新鮮血では30～50 HU）を持つ液体貯留として認められる。全身状態が許せば出血部位の同定のために造影CTを行い、特定部位の出血が疑われた場合には選択



a.



b.

図1 気管支動脈破裂による血胸（60歳代、男性）

a：突然の胸痛、呼吸困難で発症。胸部CTで左胸腔に液体貯留を認める。

b：3時間後の撮影。急速な液体貯留の増大を認める。